

I disturbi del  
comportamento  
alimentare | Seminari  
2026

Scuola universitaria professionale  
della Svizzera italiana

SUPSI

# SALUTE MENTALE

**Responsabile del modulo**

Lorenzo Pezzoli

Psicologo e psicoterapeuta FSP

Cinzia Campello

Psicologa FSP

Elisa Milani

Psicologa e psicoterapeuta FSP

Natalia Perucchi

Campopiano

Psicologa e psicoterapeuta FSP

Paola Blumer

Psicologa e psicoterapeuta FSP

Alessia Ceroni

Docente assistente

**Regista per la messa in scena**

Fabrizio Rosso

*“Quando si presentò per il consulto, sembrava uno scheletro ambulante, scarsamente abbigliata in shorts da cui le gambe uscivano come manici di scopa, e con un prendisole che lasciava vedere tutte le costole e le scapole che sporgevano a mo' di piccole ali. Disse la madre: “Se l'abbraccio, sento solo ossa, come un uccellino spaventato. [...] Alma insisteva però a dire che il suo aspetto era ottimo, non c'era niente di male nel suo essere magra. “Mi piace avere questa malattia e la voglio. Non riesco a persuadermi di essere malata e che ci sia qualcosa da cui debba guarire.” (Bruch, 1978, p. 18)*



Cara studentessa, caro studente,

l'assunzione del cibo attraverso l'allattamento, nella prima fase della vita di ognuno, è strettamente collegata ad una comunicazione profonda tra il bambino e il suo caregiver primario, esperienza unica di incontro dell'essere umano con l'Altro e il mondo. All'interno di questo scambio, secondo Molinari (2017) troviamo un impasto tra nutrizione e sessualità, soddisfazione e aggressività, sopravvivenza e riproduzione.

In questo passaggio vedremo come l'attacco al corpo possa avvenire per mezzo dell'alimentazione (o della non-alimentazione) e come ciò sia sempre indice di una profonda sofferenza. Oggigiorno, non è più solo la diffusione delle patologie “pure” dei disturbi del comportamento alimentare, anoressia nervosa e bulimia nervosa, che ci sconcerta, quanto l'incremento di tutta una serie di comportamenti al cui centro troviamo un rapporto malsano con il cibo (con sé stessi e con il mondo). Disturbi che da sempre sono stati segnalati, ad esempio, nello sviluppo infantile e che rappresentano il primo modo del bambino per esprimere sé stesso, hanno avuto un aumento esponenziale negli ultimi anni. Come mai per milioni di giovani il cibo si è trasformato in un nemico? E che tipo di rapporto con lo sviluppo dell'identità femminile hanno i fenomeni orto- e vigoressici sempre più evidenti?



*“L'uomo è un onnivoro che si nutre di carne, di vegetali e d'immaginario...; il simbolico, l'onirico, i miti e i fantasmi nutrono anch'essi e concorrono a regolamentare il nostro nutrimento. Nell'atto alimentare, uomo biologico e uomo sociale sono strettamente, misteriosamente mescolati e confusi.”*, sosteneva C. Fischer (1979). Cercheremo di capire perché il “fenomeno alimentare” sta assumendo carattere di epidemia sociale, com'è avvenuta la saldatura tra i modelli culturali di vita che stiamo vivendo e le forme patologiche, e quali sono le principali manifestazioni del disagio che viene espresso attraverso il cibo. A tale scopo, ti proponiamo la lettura del libro “Petite” di Geneviève Brisac, che racconta in modo semplice ma efficace la storia di un'anoressia.

(Elisa Milani)

## IL VALORE SOCIALE E SIMBOLICO DEL CIBO

Anche se così potrebbe sembrare, non è scontato il fatto che, incorporando e assimilando il cibo, noi “diventiamo quello che mangiamo”. Ecco che possiamo iniziare a capire come esso sia intimamente legato al concetto di sé e dell'identità. Il cibo opera simbolicamente nel definire i confini tra sé e l'altro, ed è strettamente connesso al nostro rapporto con il mondo. È attraverso l'alimentazione, infatti, che la madre presenta il mondo al bambino, è attorno all'attività orale che si sviluppano i primi scambi del neonato con l'ambiente, attività orale che soddisfa sì un bisogno biologico di nutrizione, ma che al tempo stesso rappresenta una importante fonte di appagamento. Attorno a questa modalità relazionale, che vede coinvolti un soggetto che riceve nutrimento e l'altro che lo offre, si sviluppano delle vicissitudini che caratterizzeranno la nostra personalità attraverso le prime esperienze affettive e cognitive, potendo l'atto di alimentare veicolare sia piacere che dispiacere, sia vicinanza che intrusione (Mansi, 2014). Le prime forme di relazione madre-bambino, quindi, sono regolate sulle attività alimentari che prefigurano le future relazioni che la persona avrà nel corso della propria vita.

---

**Le prime forme di relazione madre-bambino, quindi, sono regolate sulle attività alimentari che prefigurano le future relazioni che la persona avrà nel corso della propria vita**

---

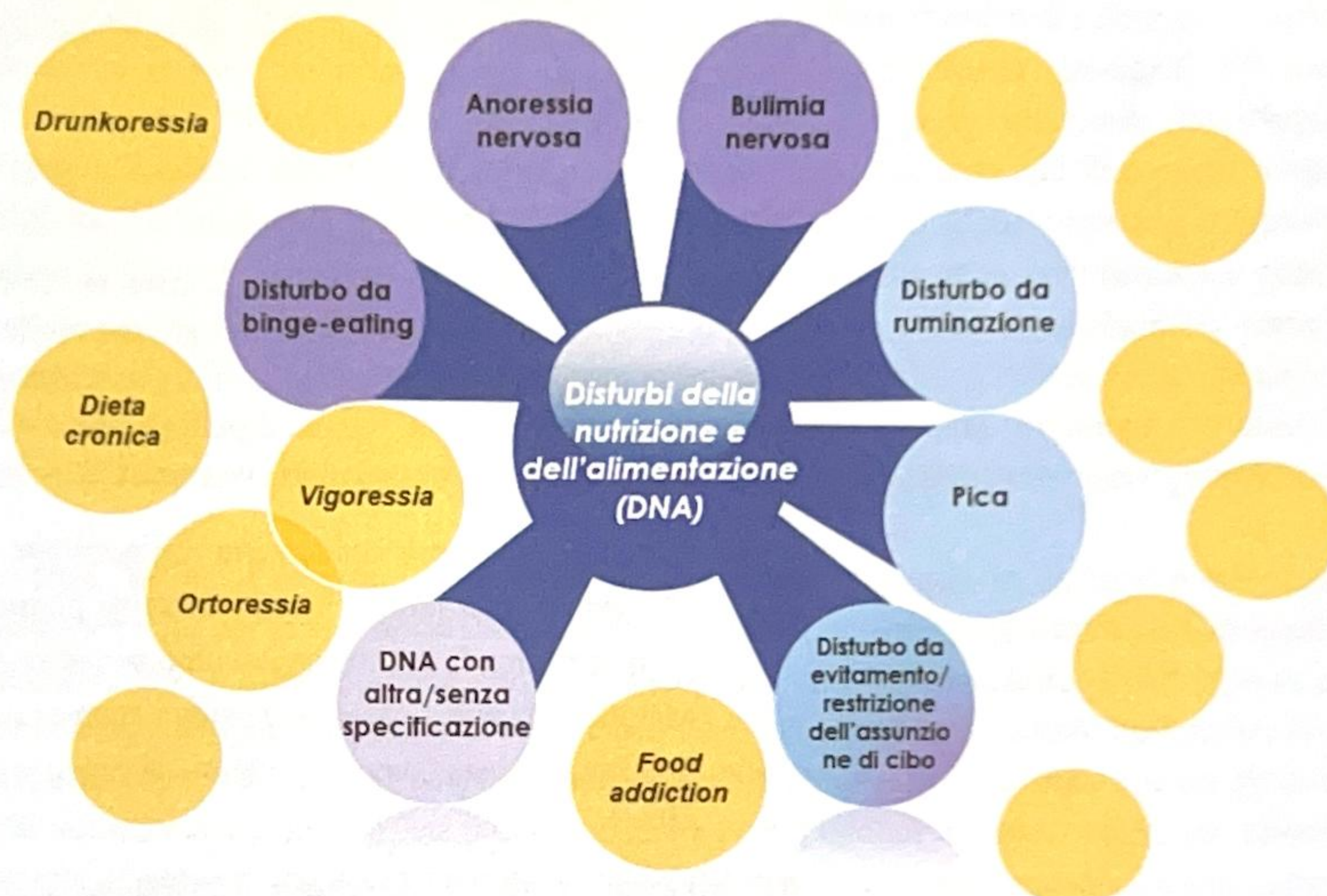
La diffusione dei disturbi del comportamento alimentare porta a riflettere, anche dal punto di vista sociologico, al valore culturale che il cibo ha da sempre nella storia dell'uomo e nella costruzione del gusto. Quale fonte di vita primordiale, il cibo ha da sempre un posto centrale nell'iconografia di tutte le epoche storiche, a partire dalle incisioni rupestri ad oggi. Ogni etnia pone il cibo al centro come elemento distintivo della propria cultura, e, anche tra i migranti, c'è spesso la necessità di mantenere, quando possibile, il pasto tradizionale del proprio popolo, quale aggregatore e forza centripeta che permette di mantenere un legame con le proprie origini e quindi con una parte della propria identità. Vi sono determinati ruoli, attese, messaggi, emozioni che il pasto assume nelle differenti occasioni di socializzazione. La costruzione del gusto stesso non avviene in funzione dell'organo sensoriale della lingua, bensì dalla sua elaborazione attraverso il cervello e tale elaborazione ha sempre a che vedere con una cultura di provenienza. Il gusto, inoltre, è strettamente legato ad un altro dei nostri sensi, l'olfatto, il quale è connesso a sua volta direttamente alle strutture cerebrali preposte alla memoria (l'ippocampo) e alle emozioni (amigdala, sistema limbico). Cosa sia buono o cattivo, quindi, dipende anche dall'insegnamento che abbiamo ricevuto nel riconoscerlo come tale, dalle nostre esperienze e, in fondo, dalla storia dell'evoluzione umana (Shepherd, 2013).



## CLASSIFICAZIONE ATTUALE



I Disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA), sono caratterizzati da *“da un persistente disturbo dell'alimentazione o di comportamenti collegati con l'alimentazione che determinano un alterato consumo o assorbimento di cibo e che danneggiano significativamente la salute fisica o il funzionamento psicosociale”* (APA, 2023, p. 445). Ad oggi costituiscono una delle patologie più preoccupanti dell'emisfero occidentale, assumendo forme e caratteristiche sempre più diversificate. Soprattutto i quadri di bulimia nervosa e disturbo da binge-eating (binge eating disorder, BED) hanno subito un continuo aumento di incidenza negli ultimi anni. Proprio quest'ultimo quadro psicopatologico è stato riconosciuto come entità a sé stante solo nel 2013 all'interno del DSM-5. I DNA, come si evince dall'immagine sottostante, vengono attualmente distinti in sei categorie, più una categoria che contempla altri disturbi alimentari che non soddisfano completamente i criteri per la classificazione.



*Disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA) secondo il DSM-5-TR (in blu) e altre manifestazioni di sofferenza legate al comportamento alimentare non ancora inserite nel manuale (in giallo).*

### Anoressia nervosa

Si parla di anoressia nervosa, secondo il DSM-5-TR (APA, 2022), quando vi è un'assunzione di calorie ristretta rispetto al necessario, che porta a un peso inferiore al minimo normale in rapporto ad età, sesso e salute fisica. Tale restrizione alimentare è accompagnata da un'intensa paura di aumentare di peso o da un comportamento persistente che interferisce con l'aumento di peso, anche se quest'ultimo risulta molto basso. Il peso e la forma del corpo vengono vissuti in modo alterato, assumendo essi un'influenza eccessiva sui livelli di autostima della persona, oppure comportando una persistente mancanza di riconoscimento della gravità della condizione di sottopeso.

Nel manuale vengono distinti due tipi di anoressia nervosa: da una parte l'AN con restrizioni, quando non sono stati presenti negli ultimi tre mesi ricorrenti episodi di abbuffate o condotte di eliminazione ed in questo caso il dimagrimento avviene con la dieta, il digiuno e/o l'esercizio fisico eccessivo; dall'altra, un tipo di AN che presenta abbuffate ricorrenti o condotte di eliminazione nello stesso periodo di tempo.

### Bulimia nervosa

Una persona che soffre di bulimia nervosa presenta episodi ricorrenti abbuffate, durante le quali ha una sensazione di perdita di controllo. Le abbuffate vengono così definite: *“Mangiare, in un periodo preciso di tempo (es. entro 2 ore), una quantità di cibo che è significativamente maggiore di quello che la maggior parte delle persone mangerebbe nello stesso tempo e in circostanze simili”*. A seguito delle abbuffate, conseguenti il senso di colpa sperimentato,



abbiamo dei ricorrenti e inappropriati comportamenti compensatori per prevenire l'aumento di peso, come vomito autoindotto, abuso di lassativi, diuretici o altri farmaci, digiuno o esercizio fisico eccessivo. Abbuffate e condotte compensatorie si verificano entrambe in media, almeno una volta alla settimana per tre mesi. Infine, l'autovalutazione è indebitamente influenzata dalla forma e dal peso corporeo (APA, 2022)

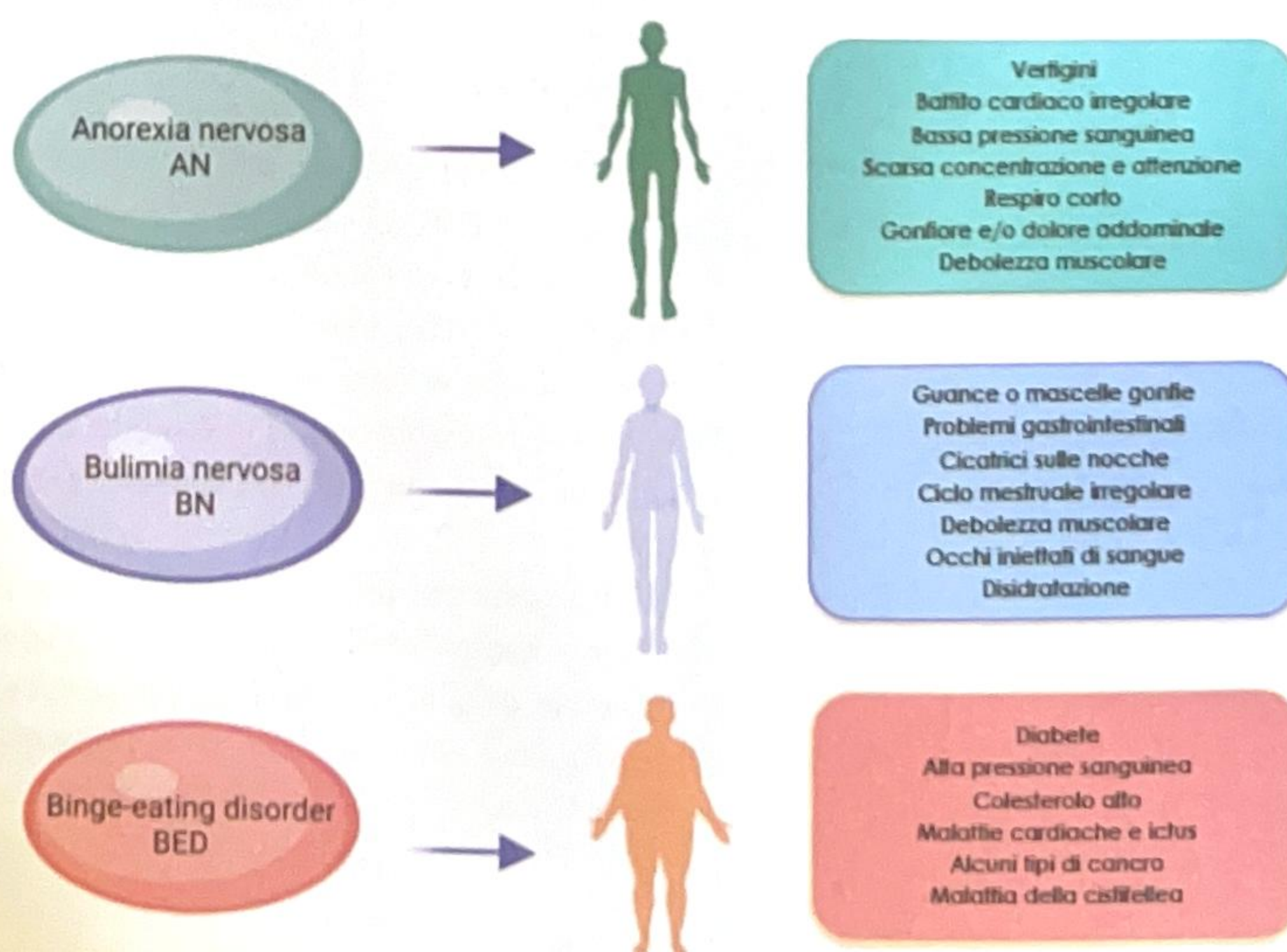
Come facilmente si può notare, i quadri che il DSM-5-TR fa di questi disturbi, presentano numerosi punti in comune, tant'è che la differenziazione tra loro sembra essere data dal fatto che nell'anoressia nervosa determinati sintomi siano presenti con sicurezza e con una chiara intensità, mentre nella bulimia nervosa possono ma non devono essere necessariamente presenti. Come già abbiamo visto sopra, inoltre, è frequente un'oscillazione tra le due sindromi nel corso della vita. È ragionevole supporre che queste due principali patologie rappresentino oggi gli estremi di un continuum fenomenologico, risultando le diverse manifestazioni divise da una soglia puramente quantitativa lungo una scala di severità clinica, piuttosto che situandosi su dei livelli qualitativi ben distinti.

### Disturbo da binge-eating

Come per la bulimia nervosa, in questo disturbo la caratteristica principale consiste in ricorrenti episodi di abbuffata, che si devono verificare mediamente almeno una volta alla settimana per tre mesi. Ciò che differenzia i due quadri, è l'assenza, in questo caso, di sistematiche condotte compensatorie inappropriate. Alcuni aspetti possono caratterizzare gli episodi di abbuffata, che devono essere anche accompagnati da una sensazione di perdita di controllo:

- Mangiare molto più rapidamente del normale;
- Mangiare fino a sentirsi sgradevolmente pieni;
- Mangiare grandi quantitativi di cibo anche se non ci si sente affamati;
- Mangiare da soli a causa dell'imbarazzo per quanto si sta mangiando;
- Sentirsi disgustati verso se stessi, depressi o molto in colpa dopo l'episodio (APA, 2022).

I tre principali quadri di anoressia nervosa, bulimia nervosa e disturbo da binge-eating comportano, tra le altre cose, numerose conseguenze evidenti a livello del corpo, alcune delle quali sono specifiche per i singoli disturbi, come è possibile notare dal riassunto schematico di Feng et al. (2023).



*I tre maggiori disturbi dell'alimentazione e alcuni sintomi a livello corporeo (Feng et al., 2023)*

### IL SINTOMO ANORESSICO DAGLI ANNI CINQUANTA IN POI

Il fenomeno anoressico, e in generale quello dei disturbi del comportamento alimentare, ha assunto negli ultimi anni una forte esposizione mediatica, che ne ha aumentato la salienza sia nell'opinione pubblica, che all'interno degli ambienti clinici. È vero che appare semplice



---

**L'anoressia era in origine una "malattia d'elezione delle ragazze di buona famiglia del mondo occidentalizzato".**

---

collegare l'aumento di questo tipo di disturbi e un certo tipo di ideali rispetto alle forme e figure delle donne (e sempre più di frequente anche degli uomini) di cui la nostra società è impregnata, e non solo a causa dell'ambiente della moda, spesso e volentieri sotto accusa. È altrettanto vero, però, che questi fenomeni non sono affatto nuovi. Possiamo infatti distinguere quattro scansioni storico-temporali a partire da metà del Novecento, che delineano una metamorfosi dei disturbi del comportamento alimentare.

La prima, l'epoca delle mosche bianche (Cosenza, 2008), è quella del boom economico degli anni Sessanta, dopo i difficili anni del dopoguerra, che vede apparire le prime pazienti anoressiche negli ospedali. Erano colpite nella stragrande maggioranza donne e adolescenti, e il sintomo era quasi esclusivamente restrittivo, mentre erano assenti le pratiche evacuative.

La seconda scansione si ritrova nelle pagine de *La gabbia d'oro* della Bruch: vi troviamo l'anoressia come "malattia d'elezione delle ragazze di buona famiglia del mondo occidentalizzato" (Bruch, 1978, 2003). È nella classe borghese emergente che l'anoressia sembra diffondersi negli anni '70, a partire dagli Stati Uniti, passando dall'Europa ma anche dal Giappone. La psichiatria rileva come il fenomeno abbia iniziato ad assumere una connotazione sociale ben precisa, e come non colpisse le fasce più povere della popolazione e non vi si trovasse segno nei paesi sottosviluppati. Anche in questo caso, si configurava come una patologia al femminile, con esordio attorno all'età puberale. Si iniziava a notare come l'ambiente della moda e della televisione giocasse un ruolo sulla diffusione dei modelli di magrezza femminile che andavano a influenzare il rapporto delle ragazze con il proprio corpo.

Gli anni '80 e '90 segnano una svolta sia per quanto riguarda la diffusione del sintomo anoressico, che per le nuove caratteristiche che assume: la forma restrittiva pura di anoressia lascia il campo a forme con pratiche di evacuazione con o senza vomito. È il tempo in cui il corpo viene riempito, colmato dal cibo, e poi svuotato, come nelle forme bulimiche, oppure trattenuto come nell'obesità che si diffonde a macchia d'olio sia tra le donne che tra gli uomini, e che spesso insorge già nell'età infantile. Anche i ceti popolari dei paesi sviluppati hanno ora accesso ai beni di prima necessità come il cibo e alla comunicazione di massa, e questi progressi portano con sé anche le patologie ad essi correlati; anoressia e bulimia concernono ora anche ragazze provenienti da famiglie più umili e non più solo quelle agiate.

Il quarto periodo storico, che parte dagli anni duemila e nel quale ci troviamo oggi, è caratterizzato, secondo Cosenza (2008), da alcuni fenomeni. Il primo accomuna i disturbi alimentari e i disturbi da sostanze: per entrambi si nota un indebolimento del paradigma della monosintomaticità e un aumento della comorbidità e del poliabuso di sostanze. Questo vuol dire che ad esempio una persona bulimica non presenta più solo i caratteristici comportamenti legati alla patologia alimentare, ma contemporaneamente abusa di alcol o cocaina, nel tentativo di arginare il proprio malessere. Sta accadendo nel panorama dei disturbi del comportamento alimentare quello che è già accaduto in quello delle tossicodipendenze: da un quadro di dipendenza pesante, invasiva, da una sostanza, si è passati ad una tossicodipendenza del "sabato sera" (Dalla Ragione & Mencarelli, 2012), in cui varie sostanze vengono consumate saltuariamente, in modo non meno pericoloso perché molto più insidioso per la mancanza di un campanello d'allarme chiaro e netto. Il secondo aspetto di cambiamento di questo millennio riguarda la diffusione: si sta assistendo ad un vero e proprio processo di globalizzazione del sintomo anoressico-bulimico, che fa la sua comparsa ormai anche nelle aree in via di sviluppo che si stanno progressivamente occidentalizzando. Quindi ritroviamo adesso anche anoressiche delle zone dell'Africa del Nord, o di parte del Medio Oriente, magari turche o israeliane (Ruggiero, 2003).





*Tavolata anoressica, San Vittore, Museo del Moesano. Foto L. Pezzoli 2022.*

L'ultimo fenomeno legato alla nostra epoca storica, riferisce Cosenza (2008) è da **mettere in relazione** con l'impiego del canale di internet e l'importanza sempre maggiore della **realtà virtuale**. L'anoressia-bulimia sembra ormai aver assunto le dimensioni di un **fenomeno collettivo**, che viene propagandato attraverso i siti pro-ana dove le adolescenti si **scambiano** consigli su come indurre il vomito o come nascondere il dimagrimento, e dove il **progresso** verso la scomparsa del proprio corpo viene accolto con gaudio dalla comunità virtuale **mentre** la cessazione della perdita di peso viene schernita. Viene promulgato un boicottaggio alle cure e quello di ana sembra diventato un culto. Di fronte ad una quotidianità dove solitamente l'Altro viene tenuto a distanza, paradossalmente sul web si crea la possibilità di entrare in contatto con un Altro che si sente simile, se non identico, e a cui ci si lega attorno a un'esaltazione dell'identità anoressica e bulimica. La passione per il sintomo diviene così una via alternativa al legame sociale. Legame sociale che si fonda non sullo scambio, sulla condivisione nel rispetto della propria identità unica e inconfondibile costruita attorno alla propria storia; il legame in questo caso si sviluppa tra identità generiche, apersonali, rappresentate da una condizione sintomatica che accomuna tutte quante (Margherita, 2013). In questo secondo millennio, in cui le questioni identitarie sono al centro delle più diffuse psicopatologie (pensiamo solo ai disturbi di personalità o alle condotte a rischio di adolescenti allo sbaraglio), il web sembra aver fornito una soluzione (spesso disfunzionale) ad aspetti identitari; e allora non c'è più il problema di un'identità incerta, traballante, ma quella che emerge e si cristallizza è un'identità fondata sul sintomo anoressico, sul rifiuto dell'Altro che viene elevato a fattore di aggregazione: "io sono ana". Si tratta certo di un'identità negativa, ma che fornisce una qualche garanzia di consistenza. Quella dell'anoressica è una diagnosi sbandierata sul web, che attira gli sguardi anche se apparentemente nella vita di tutti i giorni, fuori dalla rete, li si vorrebbe allontanare. Il sintomo diventa quindi qualcosa di prezioso, da proteggere, una proprietà del sé a cui non si può rinunciare e che regge un narcisismo fragilissimo.

## LA SCISSIONE MENTE-CORPO

Sin dal dualismo cartesiano mente-corpo, vi era l'idea che queste due entità fossero ben distinte e separate. Vi fu poi un tempo in cui, nella tradizione della religione cattolica, il corpo era considerato lo strumento del diavolo, destinato a conquistare il potere sull'anima umana, una melma di cui ci si doveva sbarazzare. A livello ontogenetico invece, l'idea che vi sia un'anima



distinta dal corpo poggia sull'esperienza del neonato che deve effettuare una vera e propria integrazione del proprio sé corporeo al proprio sé psichico. All'inizio della vita, il neonato scopre il proprio corpo, pezzo per pezzo, come lo fa per il mondo esterno, e brancola ancora per prendere le sue mani e i suoi piedi, come se fossero degli oggetti esterni. La sua psiche è soggetta a degli stimoli provenienti dal proprio corpo ma che agiscono su di essa come se fossero prodotti da degli oggetti esterni. Man mano, con lo sviluppo, questi frammenti vengono unificati sotto il controllo di un'entità psichica che riceve tutte le sensazioni di piacere e di dolore a partire dai pezzi separati (Chasseguet-Smirgel, 2003). Il dualismo della filosofia del pensiero può ormai considerarsi superato, la stretta interazione tra la mente e il corpo è innegabile e si ritrova in ognuna delle psicopatologie. Un ritorno alla scissione tra le due cose sembra però poter essere centrale nel fenomeno anoressico. Fu Mara Selvini-Palazzoli (1963) la prima ad avanzare l'ipotesi e a mettere l'accento sul fatto che, nell'anoressia, la ragazza non è spaventata dal cibo bensì dal suo stesso corpo, sostenendo che l'ingestione del cibo è vissuto come un incremento dello stesso a detrimento del proprio sé. L'adolescente, ad esempio, può sentire il proprio corpo come appartenente alla propria madre o come un nemico separato da loro stessa. Può viverlo come prova incarnata e dolorosamente persistente che si è abbandonata o arresa passivamente. Occorre tenere presente che il corpo del ragazzo nella pubertà subisce delle modifiche meno drammatiche e visibili di quelle delle ragazze, ed inoltre lo sviluppo dell'acquisizione dei caratteri sessuali secondari, differenziano definitivamente il proprio corpo da quello della madre. Al contrario, in pubertà, il corpo delle ragazze diventa simile a quello della madre. E questo può essere un problema. Nel momento in cui è necessario allontanarsi dal sé materno per acquisirne uno proprio, unico ed individuale, il corpo le riporta indietro e nel disturbo alimentare, esso diventa persecutorio, estraneo e che si impone con forza sotto l'ordine biologico rappresentato dalla madre. "Quando riuscirò a separarmi da mia madre? È come se fossi incollata a lei", raccontava una paziente alla Chasseguet-Smirgel (2003), che riporta come la stessa paziente guardandosi allo specchio vedesse il viso della madre. L'ipotesi della psicoanalista è che i disordini alimentari farebbero parte di un gruppo di patologie con scopo autartico: l'anoressica tenta di preservare l'inganno che il corpo possa vivere per sempre senza apporti esteriori. Si tratta di una vittoria dello spirito sul corpo. I disturbi alimentari sarebbero quindi al servizio dell'autonomia, dell'indipendenza, dell'illusione di bastarsi a sé stessi, lasciandosi annoverare tra le diverse forme di patologie narcisistiche.

La comprensione di questa difficoltà nella separazione e individuazione, e in particolare del ruolo giocato dalla figura materna, come si è poc'anzi illustrato, può passare anche attraverso l'utilizzazione dei miti e delle fiabe. Si potrebbe partire da una delle fiabe più conosciute in assoluto, quella di Hansel e Gretel, in cui vediamo una strega attirare i due bambini verso la casetta di marzapane con lo scopo di mangiarseli: dietro la promessa di leccornie di ogni tipo, si potrebbe rivedere simbolicamente le cure e l'accudimento alle figlie anoressiche, che celerebbero in realtà un bisogno di controllo e potere su di esse.

Anche i miti ci raccontano qualcosa in merito; rappresentando una sedimentazione del passato collettivo attraverso i secoli, essi possono essere inseriti nel presente individuale come teoria generale del funzionamento psichico. Le esperienze psicopatologiche di ognuno, che spesso vengono vissute come incomprensibili, possono in questo modo, collocate su di un orizzonte universale, trovare una chiave di lettura e, finalmente, un senso (Montecchi, 2016). Uno di questi miti, quello della ninfa Eco e Narciso narrato ne "Le Metamorfosi" di Ovidio (1971), ci illustra molto bene le difficoltà relazionali delle anoressiche e l'investimento narcisistico del corpo tipico della patologia.





*Eco e Narciso (John William Waterhouse, 1903)*

Il mito narra come Era punì Eco per aver tentato di distrarla dai tradimenti di Zeus attraverso il racconto delle sue fiabe, facendo in modo che ella non poté più parlare. Zeus mitigò in seguito tale condanna, lasciandole la possibilità di ripetere l'ultima parola che ella aveva ascoltato. Quando Eco si innamorò di Narciso, il quale era perdutoamente innamorato della propria immagine, non riuscì a farsi comprendere perché non riusciva a rivelare il suo amore, e, respinta dallo stesso, in preda alla disperazione, si lasciò morire di fame, restando di sé solo la propria voce ecolalica. Ma anche Narciso, non potendo afferrare la propria immagine che era di una bellezza sconcertante, smise di mangiare, lasciandosi scivolare nello specchio d'acqua in cui si ammirava e morendo infine affogato. Attraverso questo Mito si può rivedere come alla base della impossibilità di espressione individuale ci sia il potere di una Grande Madre (Era), la quale toglie la parola, e con essa la possibilità di comunicazione con il mondo maschile. Vediamo come il sintomo anoressico, la privazione del cibo, sia una manifestazione dell'impossibilità di comunicare in altro modo, e quindi anche della difficoltà a stabilire delle relazioni soddisfacenti, coinvolgendosi al limite con persone fragili, come lo era Narciso. Il mito e gli autori che lo hanno messo in dialogo con il problema dell'anoressia, rivedono nella dimensione fusionale che imbriglia Eco e Narciso all'interno del mondo materno, l'impedimento alla relazione con l'altro da sé (Montecchi, 2016). Narciso, inoltre, rappresenterebbe l'investimento narcisistico sul corpo, il potere e il richiamo della propria immagine corporea, che distoglie inoltre dalla voce dei propri bisogni che rimangono inascoltati.

## I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE COME SPECCHIO DEI NOSTRI TEMPI

“I disturbi del comportamento alimentare rappresentano un caso unico in ambito psichiatrico, per via del ruolo eziologico giocato dai fattori sociale e culturali”, leggiamo da Barlok e Durand (1999). Infatti, le proporzioni che hanno assunto i disturbi del comportamento alimentare, fanno pensare ad un'espansione epidemica in cui il peso dei fattori socio-culturali assume

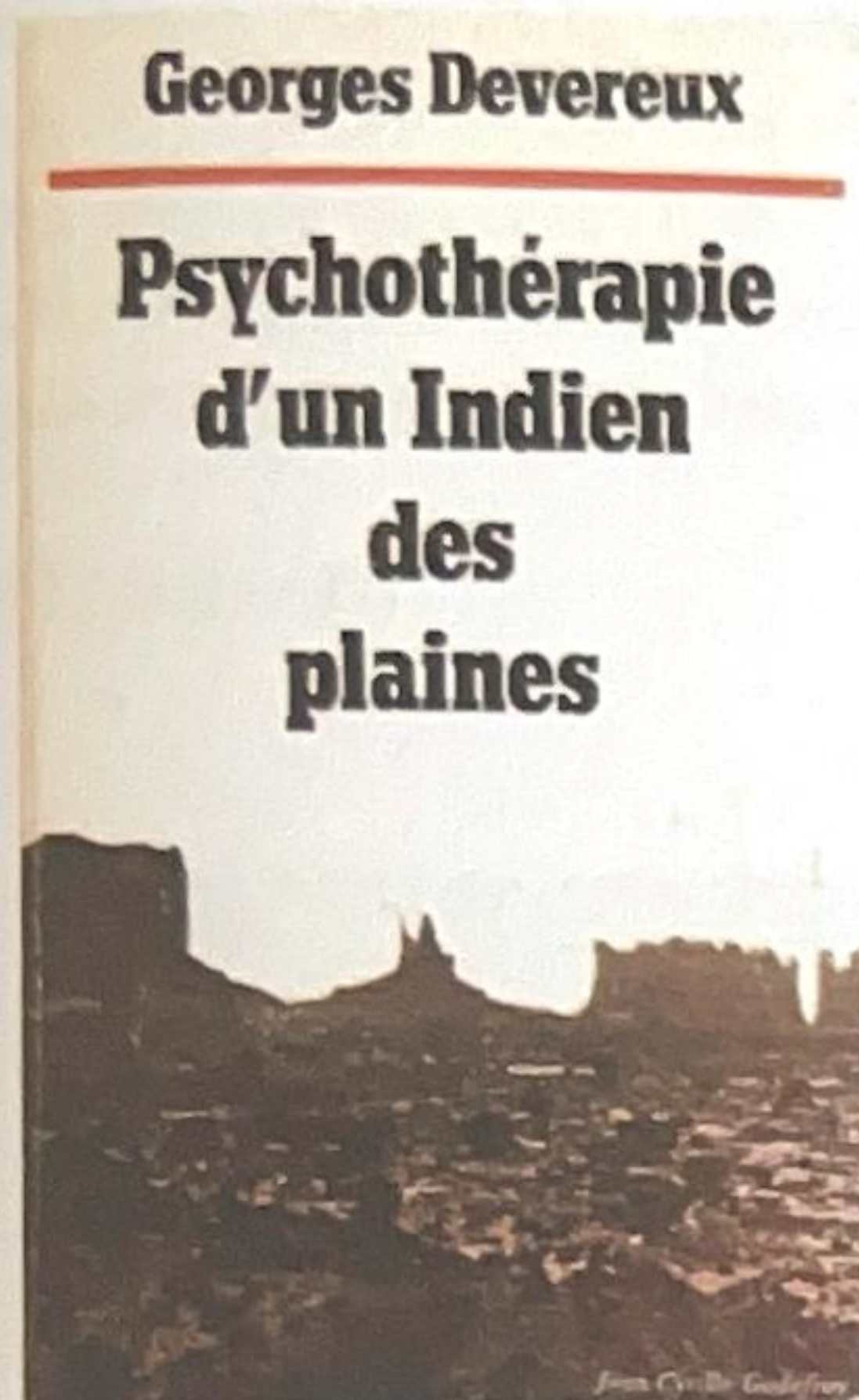
---

**Il disturbo etnico consente la strutturazione di un'identità personale attraverso una devianza socialmente tollerata.**

---

forzatamente un ruolo preminente. Decine di milioni di giovani nel mondo si ammalano ogni anno, 10 ragazze su 100 soffrono di qualche disturbo legato all'alimentazione, di queste, una o due soffrono delle forme più gravi come anoressia e bulimia, mentre le restanti si suddividono nelle numerosissime forme sottosoglia o transitorie (Dalla Ragione, Vicini & Iarrocchi, 2010).






---

**La cultura indica quale sia la forma migliore e maggiormente accettabile, in situazioni di forte stress, per esprimere il proprio malessere.**

---

Prima ancora di riflettere su fattori quali il culto dell'aspetto fisico, i conflitti legati al ruolo della donna, la spettacolarizzazione di malattie come l'anoressia da parte dei media (Gordon, 2004), è utile ricordare come ogni epoca storica sembri privilegiare una determinata malattia: ad esempio la tubercolosi nell'800, seguita dal cancro, e poi dall'AIDS negli anni Ottanta. Nel 1977 la scrittrice americana Susan Sontag nel suo testo "Malattia come metafora", sottolinea come alcune malattie siano profondamente collegate a determinate epoche storiche, tanto da diventarne il simbolo (Sontag, 1978). Un anno dopo, Georges Devereux, psicoanalista e antropologo, sviluppa il concetto di *disturbo etnico* (Devereux, 1978), che il linguaggio attuale identifica come *Culture-Bound Syndrome* (Sindromi Culturalmente Caratterizzate). Secondo l'autore, ogni cultura possiede uno o più disturbi che hanno subito una strutturazione culturale. Descrive una serie di disturbi di questo tipo, tra cui i più celebri sono l'Amok e il Latah dei Malesi, il Windigo degli Algonchini del Canada, il Cane Pazzo che vuole morire degli Indiani delle Pianure nella cultura Crow. Proprio dall'osservazione dello sviluppo di questo disturbo in un giovane guerriero nativo americano, di nome Prendi-la-pipa, vissuto ad inizio del secolo scorso, Devereux rifletterà sulla necessità di calarlo in un contesto storico-culturale specifico al fine di comprenderlo e curarlo. Nello specifico, come leggiamo nel celebre testo "Psychothérapie d'un Indien des plaines" (Devereux, 1951), Prendi-la-pipa si sarebbe azzoppato cadendo da cavallo poco prima di essere proclamato capo della sua tribù; per ricoprire tale ruolo era però necessario avventurarsi in incursioni a piedi per sottrarre del bestiame in territorio nemico ritornando alla monta di un cavallo rubato, ed essendo impossibilitato ormai il guerriero nell'adempiere a questo compito, come reazione a questa forma di stress, egli "impazzirà", divenendo Cane-pazzo-che-vuol-morire, ovvero un guerriero suicidario che ricerca a tutti i costi la morte in battaglia (Devereux, 1951). Egli notò che quando, ad esempio, uno di questi disturbi assume forme particolarmente drammatiche o rischia di creare una crisi all'interno del gruppo, possono essere attuate delle misure per controllarlo oppure sfruttarlo a proprio favore: in questo caso, al Cane pazzo veniva riservato un posto in battaglia, seppure a fini strategici non fosse particolarmente utile siccome entrava in campo disarmato (Devereux, 1978). Vediamo quindi come il substrato culturale possa influenzare individuazione, espressione e la *forma* del disagio del singolo.

Un disturbo etnico è quindi una forma di malattia che arriva ad esprimere le contraddizioni e le paure tipiche di una determinata cultura. Si può arrivare così a spiegare il perché alcune forme psicopatologiche scompaiano o diminuiscano drasticamente da un'epoca storica all'altra, e perché ne compaiano di nuove. Mutando le forme e il linguaggio attraverso cui si esprimono, psicopatologie molto diverse rispetto alla propria espressione formale e quindi diverse dal punto di vista del quadro clinico, come la Grande Isteria dell'800 e i disturbi dell'alimentazione odierni, secondo l'ottica di Devereux esprimerebbero entrambe una crisi dell'identità femminile o l'espressione critica delle contraddittorietà della stessa, ma plasmate dal contesto culturale.

Ciò significa che la cultura attuale, con l'attenzione estrema all'immagine corporea, il culto della magrezza e via dicendo, non è la "causa" dei disturbi del comportamento alimentare, quanto invece essa contribuisce a plasmare la forma entro la quale un profondo malessere si esprime e tenta una soluzione di compromesso. Non si tratta quindi di effetti *patogenetici* della cultura bensì di effetti *patoplastici* (il "Zeitstil" di Jaspers, per intenderci): i fattori patoplastici concorrono a delineare la fenomenologia del malessere, senza tuttavia determinarlo, esercitando un'azione predisponente e modellante (Dalla Ragione & Mencarelli, 2012).

Devereux sottolinea come nei casi di disturbi etnici la cultura, quindi, offrirebbe un modello di comportamento a coloro che soffrono di sofferenze mentali, fornendo alle persone delle indicazioni sulle modalità espressive da adottare, che lui chiama "modelli di cattiva condotta" (riprendendo l'espressione da Ralph Linton, antropologo americano), potendo quindi mostrare devianza e irrazionalità, pur restando in un certo qual modo all'interno di quanto è socialmente accettato. Secondo l'antropologo, la personalità non sarebbe disorganizzata a tal punto da portare il malato a rivoltarsi del tutto contro le norme sociali, ma attraverso il disturbo etnico egli riesce a farlo in modo socialmente strutturato, in una sorta di antisocialità approvata. Il disturbo individuale viene espresso quindi in forme convenzionali, che risparmiano al singolo la fatica psichica che il lavoro di elaborazione del sintomo comporterebbe. La cultura si premura

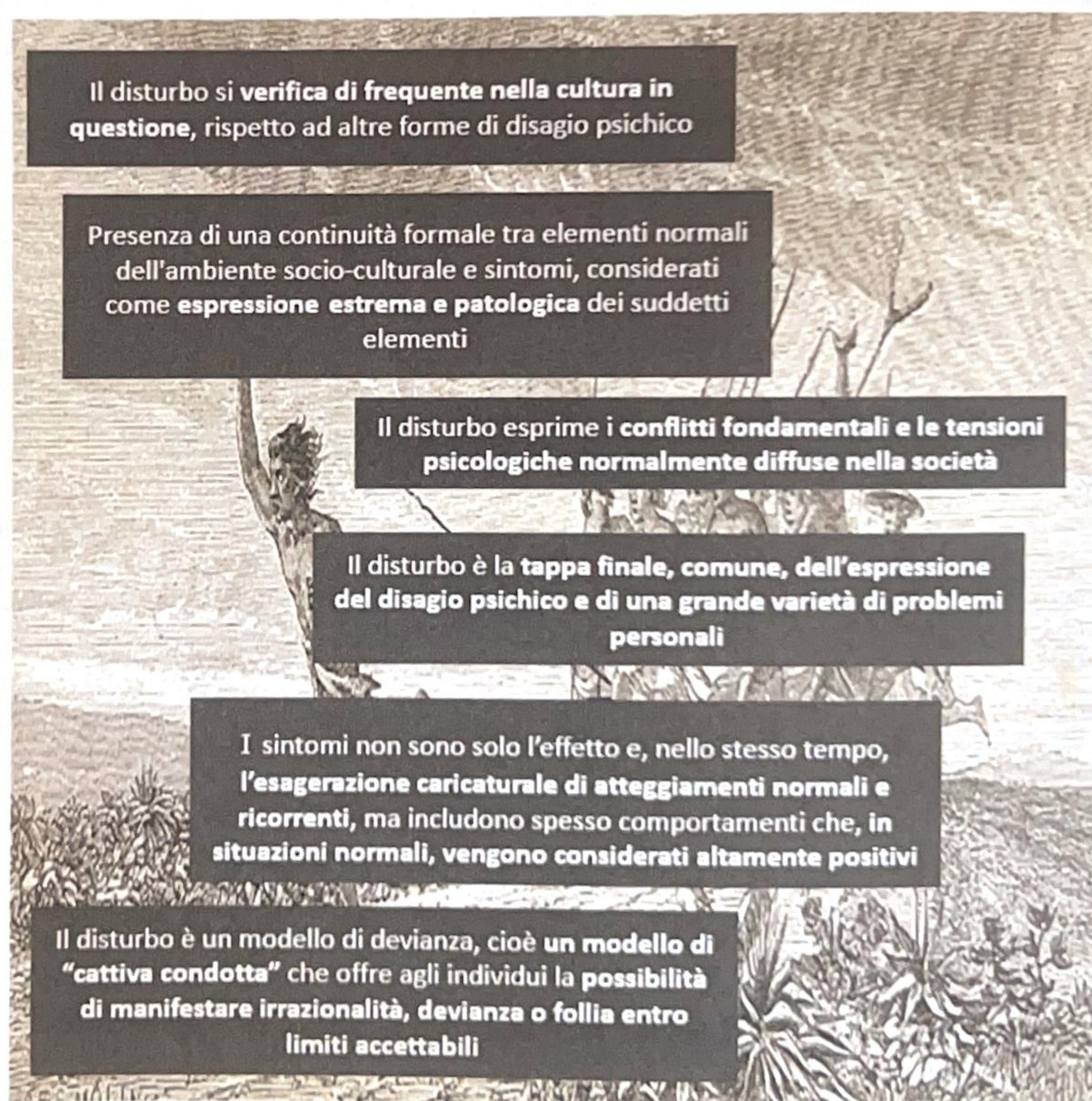


anche di dare un nome specifico al disturbo e di attribuirgli delle specifiche figure terapeutiche e procedure per curarlo o contenerlo.

Con le parole dell'antropologo, prendendo ancora ad esempio il caso di Prendi-la-pipa, vediamo come

*"A una certa "delusione insopportabile", ma rientrando in un tipo "conveniente", egli può reagire diventando un Cane Pazzo e attirarsi perciò il rispetto dei membri della sua tribù. Questa può essere, per esempio, la sua reazione se la sua ambizione di diventare capo si trovi ad essere frustrata. Ma non è autorizzato a reagire a una "delusione insopportabile" di un tipo non riconosciuto, "diventando pazzo" "in un modo qualsiasi". Se il caso si verificherà, egli si guadagnerà il rispetto altrui soltanto se reagirà ostentatamente con flemma, manifestando uno stoicismo e una indifferenza eccezionali dinanzi a ciò che il suo stesso entourage riconosce essere un colpo certamente atipico ma, nondimeno terribile".*

(Devereux, 1978)



Criteri di un disturbo etnico (Devereux, 1978)

È possibile quindi intuire il perché i sintomi di un disturbo etnico come quello anoressico, da una parte non manchino di suscitare una certa fascinazione, come il Cane Pazzo si guadagnava il rispetto dei membri della propria tribù: l'anoressica infatti mette in atto comportamenti che, in situazioni normali, vengono considerati altamente positivi: il "tenere duro" non cedendo alle tentazioni, la costanza nell'attenersi a un calendario serrato di esercizio fisico, il tentare (inizialmente, almeno) di corrispondere a un certo canone di bellezza. Quando diventano patologici, poi, tali comportamenti possono essere ammirati e stimati in segreto, forse perché, sostiene Devereux, anche altri membri di quella stessa cultura possono identificarsi



segretamente con il conflitto che i sintomi del disturbo esprimono, rappresentando essi un epifenomeno delle contraddizioni sociali che tutti percepiamo. La reazione sociale è quindi spesso ambivalente: da una parte ammirazione, dall'altra paura e ostilità (Gordon, 2004).

Una grande mole di studi evidenzia il legame esistente tra i vissuti ansiosi e depressivi scaturiti da un inadeguato sviluppo del senso della propria identità e il bisogno di ricorrere a meccanismi compensatori centrati sul comportamento alimentare. Alla luce di queste riflessioni, verrebbe spontaneo domandarsi se tra dieci, vent'anni, staremo ancora parlando dei disturbi del comportamento alimentare o se, come è avvenuto in passato per l'isteria, questi disturbi passeranno in secondo piano lasciando il posto ad un nuovo modo per esprimere la sofferenza psichica.

Quali sarebbero allora le contraddizioni sociali che contraddistinguono la contemporaneità, e a cui si può fare riferimento come suolo fertile per lo sviluppo dei disturbi del comportamento alimentare? Quali le difficoltà, che riguardano soprattutto lo sviluppo del femminile?

## TRA ORTORESSIA E VIGORESSIA, I NUOVI VALORI FEMMINILI

La fenomenologia dei disturbi alimentari si è modificata sotto molti aspetti, come descritto in precedenza, e ciò è stato notato nella sua accelerazione soprattutto a partire dall'esplosione di nuovi casi di disturbi del comportamento alimentare nel periodo della pandemia di COVID-19, ad esempio per quel che concerne le modalità con cui avviene il controllo della mente sul corpo, sui suoi desideri e le sue pulsioni: mentre in passato ciò avveniva prevalentemente attraverso la riduzione delle calorie ingerite, oggi questo avverrebbe piuttosto attraverso uno stile alimentare di tipo *ortoressico*, in cui centrale è il controllo sulla *qualità* del cibo piuttosto che sulla diminuzione delle quantità (Riva, 2022). L'ortoressia (dal greco *orthos* = corretto e *orexis* = appetito), infatti, è caratterizzata da una vera e propria ossessione dal "mangiare sano", evitando a tutti i costi quanto potrebbe essere nocivo per il corpo e la salute. Si tratta di una manifestazione che sempre più prende piede all'interno del panorama dei disturbi alimentari, seppure la mancanza di dati empirici comporti che ancora non rientri nelle classificazioni nosografiche attuali. La preoccupazione per la qualità del cibo è funzionale al raggiungimento di un corpo sempre più forte, di fronte a possibili attacchi, che siano malattie o l'invecchiamento stesso. Ma la preoccupazione per la salute può prendere proporzioni globali, includendo anche il mondo vegetale e animale, della cui protezione si diventa portavoce, aderendo a volte all'ideologia che si batte per la salvaguardia del pianeta (animalisti, ambientalisti, vegetariani, ecc.) (Riva, 2022).

A tal proposito, un antropologo della contemporaneità e divulgatore scientifico, Marino Niola (2015), ha osservato acutamente come ormai noi "*siamo quello che non mangiamo, piuttosto che il contrario*". Invece che ritrovarsi attorno ad un tavolo per condividere un pasto, luogo per eccellenza del piacere, dello scambio, nella sua analisi il pasto sarebbe diventato elemento di divisione, tanto da parlare dell'uomo globalizzato come diviso in tribù alimentari, che si differenziano a dipendenza delle loro ossessioni e dei loro tabù per quanto riguarda il cibo. Osserva come la dieta riguardi non solo il corpo ma anche una certa morale riguardante la salute e la salvezza, il cui parametro di giudizio avrebbe a che fare più con la coscienza che non con la bilancia. Ritroviamo l'atteggiamento ortoressico, in cui vengono eliminati dall'alimentazione tutti i cibi ritenuti pericolosi, alla stregua di veri e propri nemici da allontanare con il risultato di una dieta composta da scarsissimi nutrienti che alla fine vanno a detrimento della tanto ricercata salute. Niola osserva ancora, come in questa alimentazione "in sottrazione", epurata dall'elemento del piacere che contraddistingueva invece le tavolate dei nostri nonni o bisnonni, vada di pari passo con le nostre fobie: fobie di contaminazione, fobie di malattia, e via dicendo. Laura dalla Ragione, in un interessante studio sul rapporto tra intolleranze e allergie alimentari, diete e DCA (2008), osservava come una diagnosi di allergia o intolleranza alimentare colludesse con una visione ipocondriaca e paranoica del mondo, e in certi casi promuovesse un rapporto con il cibo più facilmente conflittuale e una alimentazione fortemente restrittiva e sbilanciata. La lotta contro il cibo, in sintesi, diventava una lotta contro il proprio corpo, favorendo lo sviluppo di un disturbo del comportamento alimentare.







|                                 | Anoressia nervosa moderna                                                                                              | Ortoressia e vigoressia contemporanee                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identità femminile              | Trionfo della mente sul corpo, riducendolo a scheletro<br>Rifiuto del corpo pubere e del destino femminile che incarna | Incarnata in una forma nuova, forte, sana, vincente<br>Marcatura narcisistica e diffidenza verso la dipendenza relazionale                                                                                                                            |
| Mitologia affettiva             | Declinazione ascetica e sacrificale della femminilità                                                                  | Valori estetici e prestazionali<br>Vigoressia: costruzione di un fisico forte, sano e prestazionale, per poter affrontare il mondo<br>Ortoressia: preoccupazione che riguarda la salute del proprio corpo e in estensione di tutti gli esseri viventi |
| Tema del controllo              | Con obiettivo di dimagrimento                                                                                          | Fonte di autorassicurazione fine a sé stessa (a prescindere dal desiderio di perdere peso)                                                                                                                                                            |
| Immagine corporea               | Dispercezione corporea della propria magrezza                                                                          | Bisogno di programmazione e controllo prevale sulla dispercezione, che non sempre è presente                                                                                                                                                          |
| Relazione con il cibo/desiderio | Dimensione ascetico-restrittiva, repulsione<br>Negazione del desiderio                                                 | Non è presente necessariamente disinteresse o repulsione per il cibo, rigoroso controllo della quantità o qualità<br>Controllo sul desiderio (rigido calcolo)                                                                                         |
| Peso                            | Sottopeso fino a grave magrezza                                                                                        | Sottopeso possibile, più raramente a livelli allarmanti                                                                                                                                                                                               |

Alcuni assi di differenziazione tra l'anoressia restrittiva e i nuovi fenomeni di ortoressia e vigoressia, adattamento di E. Milani da Dalla Ragione (2008) e Riva (2022)

EZIOLOGIA E PATOGENESI DEI DCA: UN QUADRO COMPLESSO MULTIFATTORIALE

Non è possibile cercare di spiegare le cause (eziologia) e i meccanismi attraverso cui si instaura il processo morboso dei DCA, senza prendere in considerazione un modello multifattoriale, dove una moltitudine di fattori si intrecciano e questo su tre livelli: si parla di fattori predisponenti, precipitanti (o attivanti) e cronicizzanti. Di seguito sono riportati alcuni esempi di questi fattori (che non possono essere riportati nella loro completezza), riguardanti in particolare i disturbi di anoressia e bulimia nervosa nella loro accezione “classica”.



Un modello multifattoriale di eziologia e patogenesi nei disturbi del comportamento alimentare.

Fattori predisponenti

Rientrano qui i fattori di rischio che possono essere genetici, psicologici o ambientali, che aumentano la vulnerabilità a sviluppare un DCA. Essi sono antecedenti l'apparire del disturbo, in quanto sono già presenti nella persona o nell'ambiente. Alcuni di questi possono essere ad esempio:

- Una **predisposizione genetica** che si può ipotizzare essere legata a determinati tipi di personalità con tratti estremi di temperamento, contraddistinti da ossessività e



perfezionismo, così come determinati fattori genetici possono predisporre non direttamente ma tramite variabili mediatrici (es. la formazione di grasso corporeo o un basso consumo di energia; una predisposizione per l'obesità infantile che può essere correlata allo sviluppo di una bulimia nervosa). Altri aspetti legati alla biologia invece possono essere un senso di sazietà dovuto a segnali errati dei meccanismi fisiologici che regolano l'appetito.

- Ritroviamo una determinata **personalità premorbose**, con caratteristiche che possono più facilmente favorire l'insorgere di instabilità dell'umore e bassa autostima. Un alto grado di perfezionismo, ad esempio, è molto frequente nelle ragazze che soffrono di anoressia nervosa: esse sono meticolose, tendono a essere molto educate e conformiste, il loro impegno è teso a fare le cose al meglio, anche in modo ossessivo e compulsivo, non essendo mai totalmente soddisfatte.
- **L'influenza della famiglia:** è noto come il comportamento alimentare della madre e i suoi atteggiamenti rispetto alla figura e al peso possano fungere da modello per i figli, così come la presenza di familiari che soffrono o hanno sofferto di un disturbo del comportamento alimentare sia un possibile fattore predisponente. Inoltre, ragazze con bulimia nervosa riportano a volte di aver subito dei commenti negativi da parte dei genitori in rapporto alla propria figura e al proprio comportamento alimentare. Un altro aspetto da prendere in considerazione è la presenza in famiglia di genitori che presentano una problematica legata all'abuso di alcol o sostanze stupefacenti: infatti, ciò favorisce l'apprendimento che la sostanza, che sia l'alcol o il cibo, possa essere un metodo per ridurre la tensione o possa fungere da "risolutore di problemi" in situazioni difficili.
- **Condizioni socioculturali:** L'ideale estremo di magrezza dei paesi industrializzati occidentali costituisce una pressione normativa molto forte sulle donne, che sentono di dover corrispondere a questo ideale. Esse imparano, infatti, che una valutazione positiva dipende dall'aspetto esteriore. Esiste un chiaro rapporto tra la stima di sé e il modo di valutare la propria figura

### Fattori precipitanti

Si tratta di eventi o situazione che scatenano l'insorgenza del disturbo. Sono i fattori che conducono una ragazza, già di per sé fragile, a sviluppare un disturbo del comportamento alimentare. Questi possono essere costituiti da lutti, aggressioni, separazioni da persone care, ma anche da eventi apparentemente non gravi come un fallimento scolastico, un cambio di scuola o essere presi in giro per il proprio aspetto. Per quanto riguarda i traumi sessuali, un collegamento eziologico sembra plausibile, dato che pazienti con DCA mostrano spesso caratteristiche che si possono ritrovare anche nelle vittime di violenze sessuali (rifiuto del proprio corpo, ecc.). Si tratta però di un fattore di rischio non specifico, i traumi sessuali aumentando il rischio di sviluppo di disturbi psichici in generale.

Anche la presenza di problemi interpersonali può fungere da fattore precipitante: avendo frequentemente di base una bassa autostima o anche dei deficit nelle competenze sociali, in situazioni di conflitto possono sperimentare un peso eccessivo che può portare ad esempio al bisogno di mangiare. A livello familiare, troviamo ad esempio situazioni dove si evidenzia uno scarso contatto emotivo, dove vi è la pressione di alte aspettative genitoriali o commenti critici sul peso.

### Fattori cronicizzanti

I fattori cronicizzanti rappresentano tutti quei fattori che impediscono il ritorno alla normalità, è l'insieme degli elementi che protraggono e rinforzano il disturbo alimentare nel tempo.

Fra questi si possono ricordare ad esempio gli effetti del digiuno prolungato: nelle ragazze sottoposte a rigide diete che portano a una riduzione del peso, avviene infatti un aumento degli stimoli biologici di protezione per la sopravvivenza che consistono in un aumento della fame, dell'appetito e dei pensieri e preoccupazioni riguardo all'alimentazione. La fame, sempre più potente, può generare nel tempo una spinta compulsiva verso il cibo. Nel caso dell'anoressia



questo provoca una paura di perdere il controllo, con conseguente aumento del controllo sulla propria alimentazione e un inasprimento della dieta, che porterà a un ulteriore calo di peso e via dicendo. Nel caso della bulimia invece, ci potrà essere la perdita del controllo e l'episodio di abbuffata con i conseguenti metodi di compenso e via dicendo.

Gli effetti del digiuno prolungato inoltre, possono condurre a disturbi cognitivi, disturbi del sonno e alla riduzione della vita sociale. I fattori cognitivi, quali la difficoltà di concentrazione, la ridotta capacità critica e l'apatia, tendono a cronicizzare la malattia sfavorendo la presa di coscienza della reale condizione del soggetto.

D'altra parte, l'alterazione della fisiologia gastrointestinale provocata dal vomito autoindotto finisce per cronicizzare frequenti infiammazioni dell'esofago, la compromissione della circolazione sanguigna intestinale e la stipsi. La grave distorsione dell'immagine corporea, poi, cronicizza il disturbo in quanto il soggetto, pur essendo gravemente dimagrito, continua a vedersi grasso, con un corpo deforme e privo di attrattiva. In questo modo persiste la necessità di dimagrire.

Quelli elencati sono solo alcuni delle componenti in gioco nei DCA, molte delle quali possono rappresentare componenti di rischio su più di un livello. Uno dei fattori trasversali che viene riconosciuto come particolarmente problematico per il processo di cronicizzazione, è probabilmente il ruolo svolto dalla famiglia.



Tavolata anoressica, prospettiva dall'alto, San Vittore, Museo del Moesano. Foto L. Pezzoli 2022.

## Petite

Geneviève Brisac, giornalista e insegnante francese, nasce in una famiglia ebrea nel 1951, a non molti anni di distanza dal macabro spettacolo dei corpi magri di Auschwitz. Parla attraverso la piccola Nouk, ragazzina tredicenne, la quale confida i suoi stati d'animo, le sue vittorie, le sue angosce. È la storia di un'adolescente intelligente e dotata che dall'oggi al domani smette di mangiare. Senza cattiveria, né follia, né con l'intenzione di rendersi interessante o di torturare la propria famiglia. Semplicemente, descrive quella malattia dell'anima che, nella sua perversione, attacca il corpo.

Così rispondeva nel 2015 in un'intervista de La Repubblica, a riguardo del suo libro.

*Ho scritto un romanzo non un saggio e, dunque, non ho risposte; lo scrittore scrive di quel che non comprende, gli dà una forma, lo interroga, lo mette in parole, lo racconta. Pone delle questioni, un po' come il filosofo. Posso solo dire: io c'ero, ci sono e ne sono uscita. Quando ho cominciato a scrivere questo libro, non mi ricordavo nulla, c'era un buco nero, una foresta opaca di dolore in cui avevo paura di addentrarmi. Ma a mano a mano che ponevo le parole sul foglio, queste si agitavano come farebbe una serpe per aprirsi un passaggio nella boscaglia.*

GENEVIÈVE BRISAC  
PETITE





"Non avrò mai più fame. Mi dissi.  
Erano le sette di sera e avevo fame. Sul carrello della cucina, la torta di noci appariva stupenda, la glassa di cioccolato luccicava. Le dissi addio per sempre. Avevo tredici anni e avevo smesso di crescere. Avevo tredici anni e avevo smesso di crescere. Non crescerò più, mi ero detta.  
Mangerò soltanto l'indispensabile. Quel che serve per sopravvivere".

(Dalla quarta di copertina)

E, mentre le mie parole tentavano una via, io vedevo le immagini spesso terribili di quella traversata. Sono dunque uscita dall'anoressia come un'avventuriera esce da una foresta, cambiata eppure uguale. Viva, e forse ancor più vibrante di vita per il fatto di aver gabbato la morte.

Provo una curiosità immensa per questa Nouk, che non è me, non lo è più da molti anni almeno, la osservo da fuori, cerco di carpire la sua voce interiore, tendo l'orecchio. Le parole allora mi giungono. Sono là perché la verità sia detta. Le adolescenti anoressiche sono oggetto di grande ostilità, la loro sofferenza è esasperante, così come il mistero che le circonda, e proprio per questo bisogna far conoscere questo vissuto, scena dopo scena, momento per momento, la cattiveria delle infermiere, la crudeltà di certi dottori, la solitudine di una ragazza di 13 anni, la violenza della cura: essere rinchiusa, privata di tutto - matita, carta, libri, giornali, radio, lettere... Sono cose che non si fanno e che lasciano una traccia per la vita.

## BIBLIOGRAFIA

- American Psychiatric Association (2023). *Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali DSM-5-TR*. Raffaello Cortina Editore.
- Barlow, D. H. & Durand, V. M. (1999). *Abnormal Psychology: An Integrative Approach*. Brooks/Cole.
- Bruch, H. (1978, 2003). *La gabbia d'oro. L'enigma dell'anoressia mentale*. Feltrinelli.
- Chasseguet-Smirgel, J. (2003). *Le corps comme miroir du monde*. Le fil rouge.
- Cosenza, D. (2008). *Il muro dell'anoressia*. Astrolabio.
- Dalla Ragione, L. (2008). *La casa delle bambine che non mangiano. Identità e nuovi disturbi del comportamento alimentare*. Il Pensiero Scientifico Editore.
- Dalla Ragione, L. & Mencarelli, S. (2012). *L'inganno allo specchio. Immagine corporea e disturbi del comportamento alimentare in adolescenza*. Franco Angeli.
- Dalla Ragione, L., Vicini, M. & Iarocchi, A. (2010). *I disturbi del comportamento alimentare – Atti del progetto Pianeta Galileo*. Regione Toscana.
- Devereux, G. (1951). *Psychothérapie d'un indien des Planes*. Paris.
- Devereux, G. (1978). *Saggi di etnopsichiatria generale*. Armando.
- Gordon, R. A. (2004). *Anoressia e bulimia. Anatomia di un'epidemia sociale*. Raffaello Cortina Editore.
- Feng, B., Harms, J., Chen, E., Gao, P., Xu, P. & He Yanlin (2023). Current discoveries and future implications of eating disorders. *Int. J. Environ. Res. Public Health*, 20, 6325.
- Manzi, G. (2014). Anoressia – Un'emergenza sociale? Spiweb.
- Margherita, G. (a cura di) (2013). *Anoressie contemporanee. Dal digiuno ascetico al blog Pro-Ana*. Franco Angeli.
- Molinari, A. (2017). *Il faut bien manger. Etnografia di un centro per i disturbi alimentari*. Tesi di dottorato. Università degli Studi di Milano-Bicocca.
- Montecchi, F. (2016). *I disturbi alimentari nell'infanzia e nell'adolescenza. Comprendere, valutare e curare. Nuova edizione*. Franco Angeli.
- Niola, M. (2015). *Homo dieteticus. Viaggio nelle tribù alimentari*. Il Mulino.
- Ovidio (1971). *Le Metamorfosi*. Zanichelli.
- Pelle, M., Procenesi, L., Contini, L. M., Siracusano, A. & Niolu, C. (2021). I disturbi alimentari e della nutrizione: nuove prospettive e nuove sfide. *Noos*, 27, 2, 75-84.
- Pope, H. G., Jr., Katz, D. L. & Hudson, J. I. (1993). Anorexia nervosa and "reverse anorexia" among male bodybuilders. *Compr Psychiatry*, 34, 406-9.
- Riva, E. (2022). *Fragili amazzoni. I disturbi alimentari delle adolescenti*. FrancoAngeli.
- Ruggiero, G. M. (a cura di) (2003). *Anoressia e bulimia nei paesi dell'area mediterranea*. Deleyva.
- Selvini-Palazzoli, M. (1963). *L'anoressia mentale*. Feltrinelli.
- Shepherd, G. A. (2013). *Neurogastronomy. How the Brain Creates Flavor and Why It Matters*. Columbia Univ Pr.
- Sontag, S. (1978). *Malattia come metafora. Il cancro e la sua mitologia*. Einaudi.